

男性尿道吊帶手術

病人須知 · 以吊帶治療前列腺手術後嘅漏尿問題

WARWIKI

男性尿道吊帶係一條軟質網帶，放喺尿道（排尿嘅管道）下面，用嚟治療漏尿問題 — 最常見係前列腺手術後，咳嗽、搬重物或活動時漏尿。吊帶托起尿道，幫你更好地控制尿液。同人工括約肌唔同，呢個唔需要任何操作。呢份資料會解釋佢點運作、點樣準備，同埋術後會點樣。

關於呢個手術

活動、咳嗽或搬重物時漏尿叫做**壓力性尿失禁 (SUI)**，常見於前列腺手術後。吊帶手術係將一條軟質網帶放喺尿道下面，輕輕托起尿道，恢復佢嘅正常位置。

吊帶係**支撐**尿道，而唔係夾實佢，所以康復後你可以**正常排尿** — 無需泵、按鈕或任何操作。

需要知嘅事

吊帶最適合**輕至中度**漏尿、括約肌功能仍有保留嘅男士，外科醫生術前會評估。若漏尿較嚴重，或曾接受**盆腔放射治療**，通常建議選用**人工尿道括約肌 (AUS)** — 醫生會同你討論邊個更適合你。吊帶可能大幅**減少**漏尿但未必完全消除，若效果唔夠，之後仍可再放AUS。

詞彙解釋

壓力性尿失禁 (SUI)

活動、咳嗽或搬重物時漏尿。

尿道

將尿液排出體外嘅管道。

吊帶 (Sling)

放喺尿道下面用嚟托起及支撐佢嘅軟質網帶。

位置確認檢查

用小型攝影機喺內部查看，確認托起尿道係咪有效。

尿瀰留

術後暫時排尿困難；可能需要短暫使用尿管。

人工尿道括約肌 (AUS)

另一種裝置，有泵，通常用於較嚴重嘅漏尿。

全身麻醉

令你喺手術期間完全睡著、唔感到痛嘅藥物。

會唔會痛？ 手術係全身麻醉或脊椎麻醉下進行，過程中唔會有感覺。術後腹股溝同埋陰囊與肛門之間嘅位置會有酸痛、腫脹同瘀青，持續一兩個星期 — 冰敷、陰囊托同止痛藥可以幫到你。手術大約需要一個鐘，好多人當日即可返屋企。

點樣準備（手術之前）

- 手術係全身麻醉或脊椎麻醉下進行 — 遵照所有手術指示（禁食，以及需要暫停邊啲藥物，包括薄血藥）。
- 尿液檢查確認有無感染（先治療），膀胱鏡檢查確認吊帶是否適合你。
- 唔好吸煙，控制體重同血糖，按指示服用抗生素 — 吊帶係網帶植入物。

請提前告知醫療團隊，如果你：

- 曾接受盆腔放射治療 — 吊帶效果可能較差，AUS 可能更合適
- 曾做過尿失禁手術，或有尿道狹窄
- 身體任何部位有感染

手術過程

- 1 你係麻醉下睡著或腰部以下失去知覺，並會注射抗生素。
- 2 外科醫生經腹股溝同陰囊與肛門之間嘅小切口，將網帶吊帶穿入尿道下方並托起到適當位置。
- 3 固定吊帶後縫合切口，通常會短暫放置一條尿管。

之後

- 腹股溝同會陰位置會有酸痛、腫脹同瘀青，持續 1–2 個星期。使用冰敷、陰囊托同止痛藥。
- 數個星期內（通常約 6 個星期）**避免搬重物、用力、踩單車同性行為** — 用力可能令吊帶未愈合時移位。
- 可能暫時有**排尿困難**，需要短暫使用尿管；通常會自行好返。
- 初期繼續使用護墊 — 改善可能係逐漸嘅。康復後**無需任何操作**，可以正常排尿。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 完全唔能夠排尿
- 發燒或發冷，或切口位置愈來愈紅腫、痛或有分泌物
- 腹股溝或會陰痛症加重

要記住嘅三件事

1. 男性尿道吊帶係一條網帶，放喺尿道下面托起支撐，改善前列腺手術後嘅尿控能力 — 無需任何操作。
2. 最適合輕至中度漏尿；漏尿嚴重或曾放射治療者，AUS 通常更好 — 需要時之後仍可再放。
3. 術後數個星期**避免搬重物、用力、踩單車同性行為**，讓吊帶穩固愈合。若完全唔能排尿或有感染跡象，即刻聯絡醫療團隊。